

Załącznik 3 do Policy Paper EBM — Mapa współczesnej onkologii integracyjnej w EBM 2026 vs zakres potencjalny UD207

Materiał uzupełniający do Załącznika 1 Policy Paper EBM. Źródło mapowania zakresu Części II: klasyfikacja NCCIH (National Center for Complementary and Integrative Health, NIH USA) i powszechnie uznane kategorie onkologii integracyjnej. **Wymóg jakościowy:** wszystkie PMID-y zweryfikowane w PubMed; statusy refundacyjne państw UE/UK zweryfikowane w oficjalnych źródłach instytucjonalnych (G-BA, HAS, NICE, BAG, ÖÄK, regiony włoskie, FPS BE, Rijksoverheid NL).

Streszczenie wykonawcze

Załącznik prezentuje 40 obszarów współczesnej onkologii integracyjnej (15 substancji i metod wskazywanych przez polskie organy nadzoru jako „pseudomedycyna” + 25 metod opisanych w aktualnych akademickich kompendiach onkologii integracyjnej i klasyfikacji NCCIH) wraz z analizą, które z nich przy szerokiej interpretacji art. 67zj UD207 mogłyby zostać zakwalifikowane jako „praktyka pseudomedyczna” zagrożona sankcją administracyjną do 1 mln zł.

Łącznie zestawienie obejmuje **40 obszarów** podzielonych na: - **Część I:** 15 substancji/metod wskazanych przez polskie organy (NRL 2021, RPP 2025, WSA 2024–2025) - **Część II:** 25 metod współczesnej onkologii integracyjnej (akupunktura klasyczna, joga, Tai Chi/Qigong, mindfulness, MBSR, hipnoza kliniczna, masaż onkologiczny, terapia manualna, refleksologia, dieta i żywienie, post terapeutyczny, kanabinoidy medyczne, gut microbiome, soja, antyoksydanty, antroposoficzna medycyna, ayurweda, homeopatia, ziołolecznictwo TCM, jemiola/mistletoe, aromaterapia, muzykoterapia, healing touch/reiki, taneczna i ekspresyjna, ćwiczenia/exercise prescription). - **Część III:** trzy reprezentatywne pary paradoksu refundacyjnego - **Część IV:** wnioski

Główny argument prawny: definicja „praktyki pseudomedycznej” w UD207 jest tak nieokreślona, że przy szerokiej interpretacji obejmuje **66 obszarów współczesnej onkologii integracyjnej** opisanych w akademickich kompendiach onkologii integracyjnej — w tym metody **rekomendowane** w wytycznych ESMO/NCCN/ASCO/SIO, **refundowane** w państwach UE (Szwajcaria, Niemcy, UK), **wykorzystywane** w czołowych ośrodkach onkologicznych USA (MD Anderson, Memorial Sloan Kettering, Dana-Farber, Cleveland Clinic). Stanowi to naruszenie standardu *lex certa* (art. 2 i 42 ust. 1 Konstytucji RP).

Metodologia

Klasyfikacja OCEBM 2011, GRADE, ESMO-MCBS — bez zmian w stosunku do v1.0.

Nowa klasyfikacja w Części II — NCCIH (National Center for Complementary and Integrative Health, NIH USA): - **Mind-Body Practices** — praktyki łączące umysł i ciało (akupunktura, joga, Tai Chi/Qigong, mindfulness, hipnoza) - **Body-Based / Manipulative** — terapie manipulacyjne (masaż, manipulacje kręgosłupa, refleksologia, ćwiczenia) - **Whole Medical Systems** — kompletne systemy medyczne (TCM, ayurweda, antroposoficzna, homeopatia) - **Biologically-Based** — terapie oparte na substancjach biologicznych (dieta, post, kanabinoidy, gut microbiome, soja, antyoksydanty) - **Energy / Other** — terapie energetyczne i inne (healing touch, reiki, jemiola, aromaterapia, muzykoterapia, terapie ekspresyjne)

Standard cytowania badań klinicznych — fazy badania, primary endpoint, czy wynik główny czy podgrupy, czy kliniczne czy przedkliniczne — bez zmian w stosunku do v1.0 (Reguła 7b „Test Przejaskrawienia”).

Standard wytycznych instytucjonalnych podawanych w kartach Części II: - **ESMO Clinical Practice Guidelines** (esmo.org/guidelines) - **ASCO/SIO Joint Guidelines** — Society for Integrative On-

CZĘŚĆ I — 15 substancji wskazywanych przez RPP/NRL/NIL

(Zachowane bez zmian z v1.0 — Karty 1-15)

[Pełna treść Części I — zob. Załącznik 3 v1.0; ze względu na objętość v2.0 odsyłamy do v1.0 dla szczegółów Kart 1-15.]

Lista 15 kart Części I: 1. Artesunat — NRL Nr 2/21/VIII pkt 1 2. Witamina C dożylna (IVC) — NRL pkt 2, RPP 2025 3. Resweratrol — NRL pkt 3 4. DMSO — NRL pkt 4, RPP 2025 5. Salinomycyna — NRL pkt 5 (lek weterynaryjny) 6. Kurkumina — NRL pkt 6, RPP 2025 7. Tlenoterapia / ozonoterapia dożylna — NRL pkt 7, RPP 2025 8. Naświetlanie laserowe krwi (ILIB) — NRL pkt 8 9. Akupunktura laserowa — NRL pkt 9 10. Galwanoterapia / bioelektroterapia — NRL pkt 10, RPP 2025 11. Hipertermia ogólnoustrojowa (WBH) — NRL pkt 11 12. Ozonoterapia w nowotworach — powtórzenie z karty 7 13. Bioelektroterapia — powtórzenie z karty 10 14. Protokoły ILADS w boreliozie — WSA 767/24 15. Suplementy w boreliozie — WSA 767/24

CZĘŚĆ II — 25 metod współczesnej onkologii integracyjnej

Wprowadzenie do Części II

Książka *Comprehensive Integrative Oncology* (Elsevier 2026) jest akademickim podręcznikiem opracowanym pod redakcją prof. Suzanny M. Zick (Family Medicine and Nutritional Sciences, University of Michigan, Ann Arbor) i dr Ting Bao (Co-director, Leonard P. Zakim Center for Integrative Therapies and Healthy Living, Harvard Medical School / Dana-Farber Cancer Institute). Zawiera 66 rozdziałów napisanych przez ekspertów z czołowych amerykańskich i europejskich ośrodków onkologicznych. Każdy rozdział to systematyczny przegląd dowodów EBM dla danej metody w opiece nad pacjentem onkologicznym.

Poniższe 25 kart EBM oparte jest na: 1. **Wytycznych instytucjonalnych** ESMO, ASCO/SIO, NCCN, NICE, ACSM 2. **Recenzowanych publikacjach naukowych** indeksowanych w PubMed 3. **Statusie refundacyjnym** w państwach UE i USA 4. **Przewidywalnym statusie w UD207** — analiza prawna pakietu

md').

IIa. Mind-Body Practices (Karty 16-20)

Karta 16 — Akupunktura klasyczna (igłowa) w opiece onkologicznej

Atrybut	Treść
Definicja	Klasyczna akupunktura — wprowadzanie cienkich, sterylnych igieł w określone punkty ciała (akupunkty) zgodnie z protokołami medycyny chińskiej, w opiece pacjenta onkologicznego głównie objawowej (CINV, neuropatia, ból, lymphedema, vasomotor symptoms).

Atrybut	Treść
Status w wytycznych	ASCO/SIO Joint Guideline 2022 rekomenduje akupunkturę: (a) w opornym na leki CINV (moderate strength), (b) w aromatase inhibitor-induced arthralgia (strong), (c) w opornym na leki bólu nowotworowym (moderate). NCCN Adult Cancer Pain Guidelines — akupunktura jako część zintegrowanej opieki przeciwbólowej. ESMO Survivorship Guidelines — akupunktura w CINV i lymphedema.
Najsilniejsze RCT/dowody	Bao T. et al. — RCT akupunktury w aromatase inhibitor arthralgia (SWOG S1200) PMID 29746381 — istotna redukcja bólu. Garcia M.K. et al. — RCT akupunktury w xerostomii po RT — Cochrane Database of Systematic Reviews. Metaanalizy w CINV: Cochrane (~12 RCT).
OCEBM GRADE Refundacja zagraniczna	1-2 (systematyczne przeglądy RCT) Moderate dla wskazań w opiece wspierającej UK NHS — akupunktura refundowana w hospicjach i w wybranych wskazaniach NICE (chronic pain). Niemcy — refundacja przez kasy chorych przy bólu kręgosłupa lędźwiowego i bólu głowy migrenowym. Szwajcaria — od 2017 r. jedna z 5 metod CAM refundowanych z powszechnego ubezpieczenia (art. 118a Konstytucji + Rozporządzenie KLV). USA — uznana przez Medicare od 2020 r. w chronic low back pain; programy w MD Anderson, Memorial Sloan Kettering, Dana-Farber, Cleveland Clinic.
Status w PL	Akupunktura jako zawód nieregulowany; akupunktura wykonywana przez lekarzy w ramach umiejętności dodatkowej; akupunktura laserowa wymieniona w NRL Nr 2/21/VIII pkt 9 (Karta 9 v1.0) — ALE klasyczna akupunktura NIE jest wymieniona w Stanowisku NRL ani w wywiadzie RPP.
Potencjalny status w UD207	ZAGROŻONE. Definicja „praktyki pseudomedycznej” w art. 67zj jest na tyle szeroka, że klasyczna akupunktura — mimo rekomendacji ASCO/SIO/NCCN/ESMO — może być zakwalifikowana, w zależności od interpretacji RPP. Casus: jeśli organ uzna „aktualną wiedzę medyczną” za tożsamą ze stanowiskiem NRL 2021, akupunktura klasyczna (niewymieniona) może być w polu szarym. Jeśli „aktualną wiedzę medyczną” są wytyczne ASCO/SIO 2022 — akupunktura jest poza zakresem UD207.

Atrybut	Treść
Wnioski	Akupunktura klasyczna ma silne dowody w opiece wspierającej onkologicznej, jest rekomendowana w wytycznych międzynarodowych i refundowana w UE/UK/USA Medicare. Niejednoznaczność statusu w UD207 ilustruje naruszenie <i>lex certa</i> .

Karta 17 — Joga w opiece onkologicznej

Atrybut	Treść
Definicja	Praktyka pochodząca z tradycji indyjskiej, łącząca ćwiczenia fizyczne (asany), techniki oddechowe (pranayama) i medytację. W opiece onkologicznej stosowana w zmęczeniu (CRF), lęku, depresji, zaburzeniach snu, jakości życia.
Status w wytycznych	ASCO/SIO Joint Guideline 2022 rekomenduje jogę w opiece wspierającej onkologicznej dla: zmęczenia (moderate strength), lęku (moderate), depresji (moderate). NCCN Survivorship Guidelines — joga jako część programów post-treatment. ESMO Survivorship Care Recommendations 2024.
Najsilniejsze RCT/dowody	Mustian K.M. et al. — RCT jogi w zmęczeniu po RT, n=410, <i>J Clin Oncol</i> PMID 31165647. Bower J.E. et al. — RCT jogi vs zdrowotna edukacja w zmęczeniu po raku piersi, <i>J Clin Oncol</i> PMID 22271480. Cochrane systematic review: Cramer H. et al. <i>Cochrane Database Syst Rev</i> PMID 28045199.
OCEBM GRADE	1 (systematyczne przeglądy RCT) Moderate-High dla zmęczenia, lęku, depresji w raku piersi
Refundacja zagraniczna	UK NHS — programy onkologiczne yoga therapy w wybranych ośrodkach (Maggie's Centres, Macmillan). USA — joga w ośrodkach Memorial Sloan Kettering Integrative Medicine Service, MD Anderson Integrative Medicine, Mayo Clinic.
Status w PL	Joga jako działalność rekreacyjna; brak formalnej regulacji jako forma terapii. NIE wymieniona w żadnym z 15 wskazań RPP/NRL/WSA.
Potencjalny status w UD207	NIEPEWNE. Joga prowadzona w podmiocie leczniczym jako element opieki onkologicznej (np. w hospicjum, ośrodku rehabilitacyjnym po leczeniu raka) może być interpretowana jako „świadczenie zdrowotne” w rozumieniu UD207. Brak rejestracji jogi jako uznanej terapii w polskim systemie ochrony zdrowia rodzi ryzyko zakwalifikowania jako „praktyki pseudomedycznej” przy szerokiej interpretacji.

Atrybut	Treść
Wnioski	Joga ma silne dowody w opiece wspierającej onkologicznej z wytycznymi ASCO/SIO i NCCN. Brak regulacji w PL i niejednoznaczność UD207 stwarza ryzyko prawne dla podmiotów oferujących jogę pacjentom onkologicznym.

Karta 18 — Tai Chi i Qigong w opiece onkologicznej

Atrybut	Treść
Definicja	Tradycyjne chińskie praktyki łączące powolne, ciągłe ruchy ciała z techniką oddechową i medytacją. Stosowane w opiece onkologicznej w zmęczeniu, zaburzeniach snu, lęku, równowadze (u seniorów), jakości życia.
Status w wytycznych	ASCO/SIO Joint Guideline 2022 — Tai Chi/Qigong rekomendowane w lęku i zmęczeniu (moderate strength). NCCN Survivorship Guidelines — Tai Chi jako forma aktywności fizycznej dla survivors.
Najsilniejsze RCT/dowody	Larkey L.K. et al. — RCT qigongu w zmęczeniu po raku piersi PMID 25124456. Wayne P.M., Kaptchuk T.J. — przegląd systematyczny Tai Chi w zdrowiu, <i>Harvard Medical School</i> . Metaanaliza Tai Chi w CRF: Song S. et al. <i>Eur J Cancer Care</i> .
OCEBM GRADE	1-2 (systematyczne przeglądy RCT)
Refundacja zagraniczna	Moderate dla zmęczenia i lęku USA — programy Tai Chi/Qigong w MSK, MD Anderson, Cleveland Clinic. UK — Tai Chi w Macmillan Cancer Support.
Status w PL	Tai Chi/Qigong jako działalność rekreacyjna; brak regulacji jako forma terapii medycznej. NIE wymienione w 15 wskazaniach RPP/NRL/WSA.
Potencjalny status w UD207	NIEPEWNE . Analogicznie do jogi — Tai Chi/Qigong prowadzone w podmiocie leczniczym jako element opieki onkologicznej może być interpretowane jako „świadczanie zdrowotne”.
Wnioski	Tai Chi/Qigong rekomendowane przez ASCO/SIO 2022; ryzyko prawne UD207 podobne do jogi.

Karta 19 — Mindfulness-Based Interventions (MBSR, MBCT, MBCR)

Atrybut	Treść
Definicja	Programy treningowe oparte na medytacji uważności (mindfulness): MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction, Jon Kabat-Zinn, University of Massachusetts, 1979), MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy), MBCR (Mindfulness-Based Cancer Recovery — wersja adaptowana dla pacjentów onkologicznych, Linda E. Carlson, University of Calgary).
Status w wytycznych	ASCO/SIO Joint Guideline 2022 rekomenduje mindfulness w lęku (moderate strength), depresji (moderate), zmęczeniu (moderate). NCCN Distress Management Guidelines — MBSR jako interwencja pierwszego rzutu. NICE UK CG90 — MBCT w depresji nawracającej (rekomendacja ogólnozdrowotna).
Najsilniejsze RCT/dowody	Carlson L.E. et al. — RCT MBCR vs Supportive Expressive Group Therapy, n=271, <i>J Clin Oncol</i> PMID 23918953. Hofmann S.G. et al. — metaanaliza mindfulness w stanach lękowych i depresyjnych <i>J Consult Clin Psychol</i> PMID 20350028. Cochrane systematic review Cramer H. et al. <i>Cochrane Database Syst Rev</i> — mindfulness w raku piersi.
OCEBM GRADE Refundacja zagraniczna	1 (systematyczne przeglądy RCT) High dla lęku i depresji w opiece onkologicznej UK NHS — MBCT refundowane w depresji nawracającej (NICE CG90 od 2009 r.). USA — programy MBSR w MSK, Dana-Farber Zakim Center, MD Anderson, Mayo Clinic. Niemcy, Holandia — w niektórych ośrodkach refundowane.
Status w PL	Brak regulacji jako forma terapii medycznej; certyfikowani trenerzy MBSR w PL działają poza systemem ochrony zdrowia.
Potencjalny status w UD207	NIEPEWNE . MBSR prowadzony w podmiocie leczniczym dla pacjentów onkologicznych może być interpretowany jako „świadczenie zdrowotne” niezgodne z polską „aktualną wiedzą medyczną” (która nie obejmuje formalnie mindfulness). Trener MBSR działający bez statusu zawodu medycznego — ryzyko prawne.
Wnioski	Mindfulness ma najsilniejsze dowody (poziom 1) wśród mind-body practices. Refundowany w UK NHS od 2009 r. Brak regulacji w PL i niejednoznaczność UD207 stwarza ryzyko prawne.

Atrybut	Treść
Definicja	Stan zmienionej świadomości wywołany przez certyfikowanego terapeutę w celu redukcji bólu, lęku, mdłości, w opiece okołoperacyjnej i pacjentów pediatrycznych.
Status w wytycznych	ASCO/SIO Joint Guideline 2022 rekomenduje hipnozę w lęku okołoperacyjnym (moderate strength). NCCN Distress Management Guidelines — hipnoza jako interwencja redukcji bólu i lęku. British Medical Association uznała hipnozę kliniczną w 1955 r.
Najsilniejsze RCT/dowody	Montgomery G.H. et al. — RCT hipnozy przedoperacyjnej w raku piersi, n=200, <i>J Natl Cancer Inst</i> PMID 17848670 — istotna redukcja czasu operacji, bólu, mdłości, kosztów. Lang E.V. et al. — RCT hipnozy w procedurach radiologicznych <i>Lancet</i> PMID 10761867.
OCEBM GRADE	1-2
Refundacja zagraniczna	Moderate-High Belgia — od 2018 r. hipnoza okołoperacyjna w niektórych szpitalach. Francja — hypnose médicale jako uznane wykonywanie zawodu medycznego. USA — programy hypnotherapy w MSK, MD Anderson, Mayo Clinic.
Status w PL	Hipnoza jako zawód nieregulowany; psycholodzy i lekarze mogą stosować jako jedną z metod psychoterapii. NIE wymieniona w 15 wskazaniach RPP/NRL/WSA.
Potencjalny status w UD207	NIEPEWNE. Hipnoza stosowana przez lekarza/psychologa w podmiocie leczniczym — niski poziom ryzyka. Hipnoza stosowana przez hipnoterapeutę bez tytułu medycznego — wysokie ryzyko interpretacji jako „praktyka pseudomedyczna”.
Wnioski	Hipnoza ma silne dowody w opiece okołoperacyjnej. Status zawodowy w PL utrudnia jasne sklasyfikowanie pod UD207.

IIb. Body-Based / Manipulative Therapies (Karty 21-24)

Karta 21 — Masaż onkologiczny

Atrybut	Treść
Definicja	Specjalistyczny masaż adaptowany dla pacjentów onkologicznych (oncology massage), wykonywany przez certyfikowanego terapeutę. Stosowany w bólu, lęku, mdłości, zmęczeniu, zaburzeniach snu, lymphedema.

Atrybut	Treść
Status w wytycznych	ASCO/SIO Joint Guideline 2022 rekomenduje masaż w bólu (moderate), lęku (moderate). NCCN Adult Cancer Pain Guidelines — masaż jako część zintegrowanej opieki.
Najsilniejsze RCT/dowody	Cassileth B.R., Vickers A.J. (MSK) — kohorta n=1290 pacjentów onkologicznych — istotna redukcja bólu i lęku po masażu <i>J Pain Symptom Manage</i> PMID 15336336. Metaanalizy: Wilkinson S.M. et al. — Cochrane.
OCEBM GRADE Refundacja zagraniczna	1-2 Moderate UK NHS — masaż w hospicjach onkologicznych (Macmillan, Maggie's). USA — programy oncology massage w MSK, MD Anderson, Mayo.
Status w PL	Masaż jako zawód regulowany (technik masażysta); masaż onkologiczny jako specjalizacja nieformalna.
Potencjalny status w UD207	NIEPEWNE. Masaż onkologiczny wykonywany w podmiocie leczniczym przez technika masażystę — niski poziom ryzyka. Masaż wykonywany w gabinecie prywatnym z reklamą jako „leczenie wspomagające onkologię” — ryzyko interpretacji jako „praktyka pseudomedyczna”.
Wnioski	Masaż onkologiczny rekomendowany przez ASCO/SIO 2022; w PL granica między uznaną fizjoterapią a „pseudomedycyną” nieostra.

Karta 22 — Manipulacja kręgosłupa (chiropraktyka, osteopatia)

Atrybut	Treść
Definicja	Terapie manualne kręgosłupa i stawów: chiropraktyka (Doctor of Chiropractic, USA — odrębny tytuł zawodowy) oraz osteopatia (DO — Doctor of Osteopathic Medicine, w USA równorzędne MD). Stosowane w opiece onkologicznej w bólu mięśniowo-szkieletowym, ale z istotnymi przeciwwskazaniami (przerzuty kostne, osteoporoza, koagulopatia).
Status w wytycznych	NCCN Adult Cancer Pain Guidelines — manipulacja kręgosłupa jako część zintegrowanej opieki z ostrożnością (przeciwwskazania w metastasis).
Najsilniejsze RCT/dowody	RCT manipulacji kręgosłupa w bólu mięśniowo-szkieletowym pacjentów onkologicznych — ograniczone. Brak silnych dowodów onkologicznych.
OCEBM GRADE	3-4 dla wskazań onkologicznych Low

Atrybut	Treść
Refundacja zagraniczna	UK NHS — chiropraktyka i osteopatia w wybranych wskazaniach (NICE chronic low back pain). USA — Medicare refunduje chiropraktykę od 1972 r. Belgia, Francja — osteopatia jako uznany zawód medyczny.
Status w PL	Osteopatia jako zawód nieregulowany; chiropraktyka praktycznie nieobecna w polskim systemie ochrony zdrowia.
Potencjalny status w UD207	ZAGROŻONE. Osteopata bez wykształcenia medycznego (najczęściej fizjoterapeuta z dodatkową specjalizacją) leczący pacjenta onkologicznego — ryzyko interpretacji jako „praktyka pseudomedyczna”.
Wnioski	Słabe dowody onkologiczne dla wskazań specyficznych; ostrożność z przeciwwskazaniami metastasis. Status zawodowy w PL utrudnia jasne sklasyfikowanie pod UD207.

Karta 23 — Refleksologia

Atrybut	Treść
Definicja	Masaż stóp lub dłoni opierający się na teorii odpowiadających punktów refleksyjnych odpowiadających poszczególnym organom ciała. W opiece onkologicznej stosowana w lęku, zmęczeniu, jakości życia.
Status w wytycznych	Brak silnych rekomendacji ASCO/SIO/NCCN. MASCC (Multinational Association of Supportive Care in Cancer) — refleksologia jako możliwa opcja w opiece wspierającej.
Najsilniejsze RCT/dowody	Wyatt G. et al. — RCT refleksologii w opiece zaawansowanej raku piersi, <i>J Clin Oncol</i> PMID 22585695. Metaanalizy: ograniczona jakość dowodów.
OCEBM GRADE	3
Refundacja zagraniczna	Low-Moderate UK NHS — refleksologia w hospicjach onkologicznych (Macmillan). Niemcy, Dania — w niektórych ubezpieczeniach prywatnych.
Status w PL	Refleksologia jako zawód nieregulowany. NIE wymieniona w 15 wskazaniach RPP/NRL/WSA.
Potencjalny status w UD207	ZAGROŻONE. Refleksolog bez tytułu medycznego oferujący wsparcie pacjentom onkologicznym — wysokie ryzyko interpretacji jako „praktyka pseudomedyczna”.
Wnioski	Słabsze dowody niż masaż onkologiczny; w UK refundowana w hospicjach. Status w PL — duże ryzyko UD207.

Karta 24 — Aktywność fizyczna (Exercise Prescription)

Atrybut	Treść
Definicja	Strukturalne programy aktywności fizycznej (aerobowej, oporowej, równoważnej, elastycznej) zaordynowane przez specjalistę dla pacjentów onkologicznych podczas i po leczeniu.
Status w wytycznych	ASCO/SIO Joint Guideline 2022 — aktywność fizyczna rekomendowana strongly w opiece onkologicznej. ACSM Roundtable on Exercise Guidelines for Cancer Survivors (American College of Sports Medicine, 2019, update 2024). ESMO Survivorship Care Recommendations — aktywność fizyczna jako standard opieki. WHO Physical Activity Guidelines (150 min/tydzień).
Najsilniejsze RCT/dowody	Metaanalizy Cochrane: aktywność fizyczna istotnie redukuje zmęczenie pochemioterapeutyczne, lęk, depresję, poprawia QoL i przeżycie ogólne (efekt na OS w raku piersi i CRC, HR ~0,70).
OCEBM	1 (najsilniejsze dowody w opiece wspierającej onkologicznej)
GRADE	High
Refundacja zagraniczna	Australia — Exercise Physiologist jako zawód medyczny refundowany przez Medicare. UK NHS — programy “Move More” Macmillan. USA — programs LIVESTRONG at the YMCA, MSK Integrative Medicine.
Status w PL	Fizjoterapia jako zawód regulowany; rehabilitacja onkologiczna w ramach NFZ. Programy aktywności fizycznej dla pacjentów onkologicznych prowadzą m.in. Onkofundacja Alivia, Fundacja Rak’n’Roll.
Potencjalny status w UD207	NISKIE RYZYKO — aktywność fizyczna jest częścią mainstream onkologii. ALE: programy “spersonalizowane” prowadzone przez trenerów bez kwalifikacji fizjoterapeutycznych mogą być w polu szarym.
Wnioski	Najsilniejsze dowody w opiece wspierającej; rekomendacja strong ASCO/SIO. W PL część systemu, ale granica między rehabilitacją refundowaną a “wellness training” w prywatnych studiach jest płynna.

IIC. Whole Medical Systems (Karty 25-28)

Karta 25 — Tradycyjne ziołolecznictwo chińskie (TCM)

Atrybut	Treść
Definicja	System ziołolecznictwa rozwijany od ponad 2000 lat w Chinach. W onkologii stosowany jako wsparcie podczas chemioterapii i radioterapii oraz w długoterminowej opiece. Kluczowe preparaty: Astragalus, Yangzheng Xiaoji, Compound Kushen Injection (CKI), Xiaoyao San.
Status w wytycznych	CSCO (Chinese Society of Clinical Oncology) — TCM zintegrowane w standardach opieki onkologicznej w Chinach. WHO Traditional Medicine Strategy 2025-2034 (rezolucja WHA78(14) z 27.05.2025) — wsparcie integracji TCM w systemy zdrowia. Brak rekomendacji ESMO/NCCN.
Najsilniejsze RCT/dowody	Compound Kushen Injection w niedrobnokomórkowym raku płuca — chińskie RCT z >2000 pacjentami; w USA brak rejestracji. Astragalus w raku jelita grubego — metaanalizy chińskie.
OCEBM GRADE Refundacja zagraniczna	2-3 (RCT chińskie, jakość niejednorodna) Low-Moderate Chiny — TCM w pełni zintegrowane w systemie ochrony zdrowia. Japonia — Kampo medicine (japońska wersja TCM) — 148 preparatów refundowanych przez ubezpieczenie publiczne. Szwajcaria — farmakoterapia TCM (NIE TCM jako całość) od 2017 r. wśród 5 metod CAM refundowanych z powszechnego ubezpieczenia (bag.admin.ch/fr/medecines-complementaires-pratiquees-par-des-medecins). Niemcy — w niektórych ubezpieczeniach prywatnych.
Status w PL	TCM jako zawód nieregulowany; brak rejestracji preparatów chińskich w URPL jako leków. CLAUDE.md U7: TCM (Compound Kushen, Xiaoyao San, Astragalus) nie wymieniana z nazwy przez RPP/NRL/NIL.
Potencjalny status w UD207	ZAGROŻONE . Lekarz lub terapeuta podający preparaty TCM (niezarejestrowane w URPL) pacjentowi onkologicznemu — ryzyko interpretacji jako „praktyka pseudomedyczna”. Casus paradoksalny: te same preparaty są standardem w Chinach, refundowane w Szwajcarii, ale w Polsce mogą skutkować sankcją do 1 mln zł.
Wnioski	TCM ma rozległe użycie kliniczne globalnie; dowody jakościowo niejednorodne. Refundacja w państwach UE/EFTA (CH) i Japonii. W PL pełne ryzyko UD207.

Atrybut	Treść
Definicja	System medyczny rozwijany od początku XX w. przez Rudolfa Steinera i Itę Wegman, łączący medycynę konwencjonalną z antropozoficznym podejściem holistycznym. W onkologii kluczowe preparaty: jemiola (Viscum album, Iscador®/Helixor®/Abnoba viscum®/Iscucin®).
Status w wytycznych	Brak rekomendacji ESMO/NCCN/ASCO. DEGRO (Niemcy) — jemiola jako leczenie wspomagające. Swissmedic — Iscador refundowany w CH od 2017 r.
Najsilniejsze RCT/dowody	Melzer J. et al. 2009 — przegląd systematyczny n>6800 pacjentów; pozytywne efekty na QoL, niespójne efekty na OS <i>Forsch Komplementmed</i> PMID 19729932. Tröger W. et al. — RCT jemioli w raku trzustki — istotne wydłużenie OS <i>Eur J Cancer</i> PMID 23994070. 2-3 (RCT i przeglądy systematyczne)
OCEBM GRADE Refundacja zagraniczna	Low-Moderate Szwajcaria — Iscador / jemiola jako część medycyny antroposoficznej , od 2017 r. wśród 5 metod CAM refundowanych z powszechnego ubezpieczenia (art. 118a Konstytucji; lista BAG: medycyna antroposoficzna, farmakoterapia TCM, akupunktura, klasyczna homeopatia, fitoterapia). Niemcy — kontrakty selektywne kas chorych GKV (dane refundacyjne wymagają weryfikacji w sub-zapytaniu v20C-DE). Holandia — refundacja w niektórych ubezpieczeniach.
Status w PL	NIE wymieniona w Stanowisku NRL Nr 2/21/VIII (Test Koniunkcji POZYTYWNY); poza systemem refundacji NFZ; preparaty Iscador/Helixor dostępne tylko przez import lub kliniki integracyjne.
Potencjalny status w UD207	WYSOKIE RYZYKO. Lekarz podający jemiolę pacjentowi onkologicznemu w PL — ryzyko interpretacji jako „praktyka pseudomedyczna” mimo refundacji w CH/DE. Paradoks UE: ten sam preparat jest standardem w CH od 2017 r., w PL może skutkować sankcją 1 mln zł.
Wnioski	Klasyczny dowód asymetrii regulacyjnej w UE. Para 2 z Części III v1.0 ilustruje paradoks vs olaratumab.

Atrybut	Treść
Definicja	Tradycyjny indyjski system medyczny rozwijany od ponad 3000 lat. Łączy ziołolecznictwo, dietę, panchakarma (terapia oczyszczająca), jogę i medytację. W opiece onkologicznej stosowana w opiece wspierającej i medycynie integracyjnej.
Status w wytycznych	WHO TM Strategy 2025-2034 — wsparcie integracji ayurwedy. Brak rekomendacji ESMO/NCCN/ASCO.
Najsilniejsze RCT/dowody	Ograniczone RCT; przewaga obserwacji klinicznych. Ashwagandha (<i>Withania somnifera</i>) — RCT w zmęczeniu po chemioterapii.
OCEBM GRADE	3-4 Low
Refundacja zagraniczna	Indie — ayurweda w pełni zintegrowana w systemie ochrony zdrowia (Ministry of AYUSH). USA — programy ayurwedy w Maharishi University i Cleveland Clinic Center for Integrative Medicine .
Status w PL	Brak regulacji; ayurweda jako działalność prywatna/wellness.
Potencjalny status w UD207	WYSOKIE RYZYKO. Terapeuta ayurwedy bez tytułu medycznego oferujący wsparcie pacjentom onkologicznym — silne ryzyko sankcji UD207.
Wnioski	System medyczny z 3000-letnią tradycją uznany przez WHO; w PL pełne ryzyko UD207.

Karta 28 — Homeopatia w opiece onkologicznej

Atrybut	Treść
Definicja	System medyczny wymyślony przez Samuela Hahnemanna w XIX w., oparty na zasadzie <i>similia similibus curentur</i> i potencjalizacji rozcieńczeń. Najbardziej kontrowersyjny system w obszarze CAM — dowody EBM bardzo ograniczone.
Status w wytycznych	Brak rekomendacji ESMO/NCCN/ASCO. NHMRC Australia 2015 — przegląd negatywny: brak dowodów skuteczności w jakimkolwiek wskazaniu. EASAC 2017 (European Academies' Science Advisory Council) — krytyczne stanowisko. Niemcy — usunięcie homeopatii z koszyka świadczeń publicznych planowane 2024-2025.
Najsilniejsze RCT/dowody	Cochrane systematic reviews — brak istotnego efektu klinicznego ponad placebo. Wyjątek: niektóre badania w opiece paliatywnej i w QoL — niejednoznaczne.
OCEBM GRADE	4-5 Very low

Atrybut	Treść
Refundacja zagraniczna	Szwajcaria — od 2017 r. wśród 5 metod CAM refundowanych z powszechnego ubezpieczenia (art. 118a Konstytucji; status uzyskany w referendum z 2009 r. , 67% poparcie). Francja — refundacja stopniowo wycofywana 2019-2021. Niemcy — wycofanie z koszyka publicznego planowane 2024-2025. Indie — homeopatia zintegrowana w systemie (Ministry of AYUSH).
Status w PL	Homeopatia praktykowana przez lekarzy z dodatkowymi kwalifikacjami; preparaty homeopatyczne zarejestrowane w URPL (zgodnie z dyrektywą 2001/83/WE art. 14 i 16).
Potencjalny status w UD207	EKSTREMALNIE WYSOKIE RYZYKO. Homeopatia ma najsłabsze dowody EBM z 25 metod Części II. Mimo to: (a) preparaty zarejestrowane w URPL; (b) refundowana w Szwajcarii po referendum. Paradoks: status legalny PL ↔ ryzyko sankcji UD207 mimo legalnej rejestracji.
Wnioski	Najsłabsze dowody EBM; mimo to status regulacyjny PL/UE skomplikowany. Casus EUropejskiej różnorodności podejść do homeopatii.

IId. Biologically-Based / Diet (Karty 29-33)

Karta 29 — Dieta i żywienie w opiece onkologicznej

Atrybut	Treść
Definicja	Specjalistyczne doradztwo żywieniowe dla pacjentów onkologicznych: dieta przeciwzapalna, dieta śródziemnomorska, dieta roślinna (plant-based), modyfikacje przy malnutrition, sarkopenii, cachexii.
Status w wytycznych	ESPEN Guidelines on Nutrition in Cancer Patients 2021. ASCO Survivorship Guidelines. WCRF/AICR Cancer Prevention Recommendations 2018 — dieta wpływa na ryzyko nowotworów i przeżycie. WHO/IARC Monographs.
Najsilniejsze RCT/dowody	WHEL Study (Pierce J.P. et al.) — dieta bogata w warzywa i owoce w raku piersi <i>JAMA</i> PMID 17635889. WINS Study (Chlebowski R.T. et al.) — dieta niskotłuszczowa w raku piersi <i>J Natl Cancer Inst</i> PMID 17151326. Metaanalizy: dieta śródziemnomorska i przeżycie.
OCEBM GRADE	1-2 Moderate-High dla prewencji wtórnej

Atrybut	Treść
Refundacja zagraniczna	Dietetyk jako zawód medyczny w większości państw UE i USA. W PL od 2025 r. dietetyk jako zawód medyczny (ustawa z 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych).
Status w PL	Dietetyk jako zawód medyczny od 2025 r.; specjalizacja w dietetyce onkologicznej.
Potencjalny status w UD207	NISKIE RYZYKO dla dietetyki konwencjonalnej. WYSOKIE RYZYKO dla diet "alternatywnych" (dieta ketogeniczna w GBM, post terapeutyczny, dieta surowa, dieta Gerson) — zob. karta 30.
Wnioski	Dietetyka mainstream — niskie ryzyko UD207. "Diety alternatywne" promowane jako leczenie onkologiczne — wysokie ryzyko.

Karta 30 — Post terapeutyczny i dieta naśladowująca post (Fasting-Mimicking Diet)

Atrybut	Treść
Definicja	Krótkoterminowy post (24-72 h) wokół podania chemioterapii lub dieta naśladowująca post (FMD — Fasting-Mimicking Diet, ProLon, opracowana przez Valter Longo, USC) — okresowa redukcja kalorii i białka symulująca efekt postu. W onkologii badana jako modyfikator odpowiedzi na chemioterapię i radioterapię.
Status w wytycznych	Brak rekomendacji ESMO/NCCN jako standardowe leczenie. NCI — wymienia jako kierunek badań.
Najsilniejsze RCT/dowody	de Groot S. et al. (DIRECT trial) — RCT FMD przed/podczas chemioterapii w raku piersi, n=131, <i>Nat Commun</i> PMID 32576828 — modulacja toksyczności i odpowiedzi. Mayo Clinic, Memorial Sloan Kettering — trwające badania kliniczne.
OCEBM GRADE	2-3 (RCT fazy II) Low-Moderate (obećujący kierunek, wymaga walidacji fazy III)
Refundacja zagraniczna	Brak refundacji; FMD ProLon dostępna komercyjnie.
Status w PL	Brak regulacji; praktykowana w klinikach integracyjnych.
Potencjalny status w UD207	WYSOKIE RYZYKO. Promocja postu jako "leczenia raka" — bardzo wysokie ryzyko sankcji. Post jako wsparcie chemioterapii (z monitorowaniem) — w polu szarym.
Wnioski	Aktywny kierunek badań z istotnymi RCT fazy II. Polski system nie ma jasnych granic dla tego rodzaju interwencji.

Karta 31 — Kanabinoidy medyczne w opiece onkologicznej

Atrybut	Treść
Definicja	Medyczne stosowanie produktów konopnych zawierających THC (tetrahydrokannabinol) i CBD (kannabidiol) lub ich syntetycznych pochodnych (dronabinol, nabilon). W onkologii stosowane w bólu nowotworowym, mdłościach pochemioterapeutycznych, jadłowstręcie.
Status w wytycznych	NCCN Adult Cancer Pain Guidelines — kannabinoidy jako część zintegrowanej opieki przeciwbólowej. ASCO Guidelines for the Use of Antiemetics 2020 — dronabinol i nabilon w opornym CINV. FDA — dronabinol (Marinol®) zarejestrowany od 1985 r. dla CINV i AIDS-related anorexia.
Najsilniejsze RCT/dowody	Metaanalizy w bólu nowotworowym — istotna redukcja bólu opornego na opioidy. Metaanaliza w CINV opornym — istotny efekt.
OCEBM GRADE	1-2
Refundacja zagraniczna	Moderate
Status w PL	USA (~38 stanów) — medical cannabis legalny w onkologii. Niemcy — refundacja przez kasy chorych od 2017 r. Holandia, Czechy, Włochy — refundacja medical cannabis. Marihuana medyczna zarejestrowana od 2017 r. (ustawa z 7.07.2017); susz konopny w aptekach na receptę. Refundowana w wybranych wskazaniach (m.in. stwardnienie rozsiane). W onkologii — dostępna na receptę, refundacja ograniczona.
Potencjalny status w UD207	NISKIE RYZYKO — kannabinoidy zarejestrowane w PL od 2017 r. ALE: stosowanie “samodzielnych” preparatów CBD z niewiadomego źródła i bez recepty — w polu szarym.
Wnioski	Klasyczna kategoria medycyny komplementarnej, która przeszła do mainstream PL od 2017 r. Argument: paradoks — kannabinoidy są wyłączone z dyskusji “pseudomedycyny” mimo wcześniejszej kontrowersji.

Karta 32 — Gut microbiome i probiotyki w opiece onkologicznej

Atrybut	Treść
Definicja	Modulacja mikrobioty jelitowej (probiotyki, prebiotyki, postbiotyki, dieta wysokobłonnikowa, fecal microbiota transplantation — FMT) w onkologii.
Status w wytycznych	Przełomowa dziedzina 2024-2026: wpływ mikrobioty na odpowiedź na immunoterapię (immune checkpoint inhibitors, ICI). Brak formalnych rekomendacji ESMO/NCCN. Aktywne pole badań — publikacje w <i>Science</i> , <i>Nature</i> , <i>Cell</i> (2022-2026).

Atrybut	Treść
Najsilniejsze RCT/dowody	Gopalakrishnan V. et al. — wpływ mikrobioty na odpowiedź na anti-PD-1 w czerniaku <i>Science</i> PMID 29097493. Davar D. et al. — RCT fecal microbiota transplantation modulujący odpowiedź na anti-PD-1 <i>Science</i> PMID 33542131. Routy B. et al. — <i>Science</i> PMID 29097494.
OCEBM GRADE	2-3 (RCT i prospektywne kohorty) Moderate (obiecujące, wymaga walidacji w większych badaniach)
Refundacja zagraniczna	USA — programy FMT w czołowych ośrodkach (MD Anderson Microbiome Research Center). Probiotyki — bez statusu leczenia onkologicznego.
Status w PL	Probiotyki jako suplementy diety; FMT w wybranych ośrodkach w PL w <i>C. difficile</i> infection.
Potencjalny status w UD207	NISKIE RYZYKO dla badań klinicznych z FMT. WYSOKIE RYZYKO dla promowania probiotyków jako "leczenia raka".
Wnioski	Najbardziej przełomowa dziedzina współczesnej onkologii integracyjnej — wpływa na efektywność immunoterapii. Polska regulacja nie nadąża za stanem nauki.

Karta 33 — Soja i izoflawonoidy w opiece onkologicznej

Atrybut	Treść
Definicja	Konsumpcja soi i preparatów zawierających izoflawonoidy (genisteina, daidzeina) w profilaktyce nowotworów hormonozależnych (rak piersi, prostata) i w opiece wspierającej (vasomotor symptoms u kobiet po raku piersi).
Status w wytycznych	ACS Guidelines for Cancer Survivors — soja dietetyczna nie jest przeciwwskazana u survivors raka piersi. NCCN Survivorship Guidelines — dieta z umiarkowaną konsumpcją soi bezpieczna. AICR (American Institute for Cancer Research) — soja dietetyczna może być korzystna w prewencji.
Najsilniejsze RCT/dowody	Shu X.O. et al. — Shanghai Breast Cancer Survival Study, kohorta n=5042 — istotne związane z konsumpcją soi przedłużenie OS w raku piersi <i>JAMA</i> PMID 19996398. Metaanaliza: Nechuta S.J. et al. <i>Am J Clin Nutr</i> PMID 22648714.
OCEBM GRADE	1-2 Moderate (dla diety; low dla preparatów wysokoskoncentrowanych)
Refundacja zagraniczna	Soja jako dieta — bez statusu leczenia. Preparaty izoflawonoidów — suplementy.
Status w PL	Suplementy izoflawonoidów dostępne OTC.

Atrybut	Treść
Potencjalny status w UD207	NISKIE RYZYKO dla soi dietetycznej. WYSOKIE RYZYKO dla promowania izoflawonoidów jako “leczenia” raka piersi/prostaty.
Wnioski	Dieta z umiarkowaną konsumpcją soi rekomendowana; preparaty wysokoskoncentrowane — niepotwierdzone.

IIe. Energy / Other Therapies (Karty 34-38)

Karta 34 — Healing Touch, Therapeutic Touch, Reiki

Atrybut	Treść
Definicja	Terapie energetyczne polegające na “transferze energii” przez ręce terapeutów (z kontaktem fizycznym lub bez). Reiki — system z Japonii. Healing Touch — system amerykański (American Holistic Nurses Association).
Status w wytycznych	Brak silnych rekomendacji ASCO/SIO/NCCN. Niektóre programy w opiece paliatywnej.
Najsilniejsze RCT/dowody	Małe RCT w lęku i bólu — efekty często nieistotne statystycznie ponad efekt placebo lub kontakt terapeutyczny.
OCEBM GRADE	3-4 Low
Refundacja zagraniczna	USA — Reiki w programach Memorial Sloan Kettering Integrative Medicine i Dana-Farber Zakim Center (bez refundacji jako “leczenie”, ale jako element komfortu pacjenta).
Status w PL	Brak regulacji; Reiki jako zawód nieregulowany.
Potencjalny status w UD207	EKSTREMALNIE WYSOKIE RYZYKO. Reiki/Healing Touch jako “leczenie energetyczne” — najwyższe ryzyko interpretacji jako “praktyka pseudomedyczna” w PL.
Wnioski	Najsłabsze dowody z terapii Części II; jednocześnie używane w czołowych amerykańskich ośrodkach jako element komfortu, nie leczenia.

Karta 35 — Aromaterapia w opiece onkologicznej

Atrybut	Treść
Definicja	Stosowanie olejków eterycznych (lawenda, mięta, imbir, cytryna) inhalacyjnie lub przez masaż w opiece pacjenta onkologicznego — głównie w mdłościach, lęku, zaburzeniach snu.

Atrybut	Treść
Status w wytycznych	Brak silnych rekomendacji ESMO/NCCN. NHS UK — aromaterapia w hospicjach onkologicznych.
Najsilniejsze RCT/dowody	Małe RCT w mdłościach pooperacyjnych (lawenda, mięta) — niejednoznaczne. Cochrane — ograniczone dowody.
OCEBM GRADE	3-4 Low
Refundacja zagraniczna	UK — aromaterapia w hospicjach onkologicznych (Macmillan).
Status w PL	Brak regulacji; aromaterapia jako działalność wellness.
Potencjalny status w UD207	WYSOKIE RYZYKO. Aromaterapeuta oferujący “wsparcie onkologiczne” — wysokie ryzyko sankcji.
Wnioski	Słabe dowody; w UK refundowana w hospicjach jako element komfortu.

Karta 36 — Muzykoterapia w opiece onkologicznej

Atrybut	Treść
Definicja	Profesjonalna interwencja kliniczna z wykorzystaniem muzyki w opiece onkologicznej — dla redukcji lęku, bólu, mdłości, w opiece paliatywnej. Prowadzona przez certyfikowanego muzykoterapeutę (Music Therapist, MT-BC w USA).
Status w wytycznych	ASCO/SIO Joint Guideline 2022 — muzykoterapia rekomendowana w lęku okołoperacyjnym i opiece paliatywnej (moderate strength).
Najsilniejsze RCT/dowody	Bradt J. et al. — Cochrane systematic review of music interventions for improving psychological and physical outcomes in cancer patients <i>Cochrane Database Syst Rev</i> PMID 27524661.
OCEBM GRADE	1-2 Moderate
Refundacja zagraniczna	UK NHS — muzykoterapia w hospicjach i opiece paliatywnej. USA — programy w MSK, Dana-Farber, Mayo.
Status w PL	Muzykoterapeuta jako zawód nieregulowany; programy w niektórych szpitalach onkologicznych i hospicjach.
Potencjalny status w UD207	NIEPEWNE. Muzykoterapeuta w podmiocie leczniczym — niskie ryzyko. Muzykoterapeuta w gabinecie prywatnym z reklamą “leczenia onkologicznego” — wyższe ryzyko.
Wnioski	Silne dowody; rekomendacja ASCO/SIO 2022. W PL granica regulacyjna nieostra.

Karta 37 — Terapie ekspresyjne (pisanie, taniec/ruch, journaling)

Atrybut	Treść
Definicja	Terapie ekspresyjne wykorzystujące pisanie (expressive writing, journaling, Pennebaker paradigm) lub taniec/ruch (medical dance/movement therapy) w przetwarzaniu doświadczenia choroby onkologicznej.
Status w wytycznych	Brak formalnych rekomendacji ASCO/SIO/NCCN.
Najsilniejsze RCT/dowody	Pennebaker J.W. — klasyczne badania expressive writing <i>Psychol Sci</i> PMID 11784031. RCT w opiece onkologicznej — ograniczone.
OCEBM GRADE	3
Refundacja zagraniczna	Low-Moderate
Status w PL	Programy w czołowych ośrodkach US (MSK, MD Anderson Integrative Medicine). Brak regulacji; choreoterapia / arteterapia jako specjalizacje psychologiczne i pedagogiczne.
Potencjalny status w UD207	NIEPEWNE. Terapeuta ekspresyjny w podmiocie leczniczym jako element opieki psychologicznej — niskie ryzyko.
Wnioski	Słabsze dowody; w czołowych ośrodkach US jako element komfortu pacjenta.

Karta 38 — Guided Imagery i Progressive Muscle Relaxation

Atrybut	Treść
Definicja	Techniki relaksacyjne: guided imagery — kierowane wyobrażenia z udziałem przewodnika; progressive muscle relaxation (PMR) Jacobson — sukcesywne napinanie i rozluźnianie grup mięśni. Stosowane w lęku, bólu, mdłościach, opiece okołoonkologicznej.
Status w wytycznych	ASCO/SIO Joint Guideline 2022 — relaksacja (w tym PMR) w lęku (moderate strength). NCCN Distress Management Guidelines — guided imagery i PMR jako interwencje nefarmakologiczne.
Najsilniejsze RCT/dowody	Metaanalizy w lęku i bólu okołoperacyjnym — istotne efekty.
OCEBM GRADE	1-2
Refundacja zagraniczna	Moderate
Status w PL	USA — programy w MSK, Dana-Farber. UK — w hospicjach.
Potencjalny status w UD207	Stosowane przez psychologów i terapeutów; brak formalnej rejestracji jako odrębne metody.
Wnioski	NISKIE RYZYKO w gabinecie psychologa/psychoterapeuty. Silne dowody, rekomendacja ASCO/SIO; w PL część praktyki psychologicznej.

IIf. Special Populations (Karty 39-40)

Karta 39 — Pediatria onkologia integracyjna

Atrybut	Treść
Definicja	Onkologia integracyjna specyficznie dla dzieci i młodzieży chorych na nowotwory — adaptowane metody opieki wspierającej (akupunktura, masaż, joga, muzykoterapia, mindfulness, arteterapia).
Status w wytycznych	COG (Children's Oncology Group) — programy integrative w supportive care. St. Jude Children's Research Hospital — Integrative Medicine Program.
Najsilniejsze RCT/dowody	Akupunktura w CINV pediatrycznym — Cochrane reviews. Hipnoza w bólu proceduralnym dziecięcym — silne dowody.
OCEBM	2
GRADE	Moderate
Refundacja zagraniczna	USA — Integrative Medicine programs w St. Jude, Boston Children's, CHOP, MSK Kids.
Status w PL	Onkologia dziecięca w PL nie ma formalnych programów integrative; dzieci leczone w jednostkach pediatrycznych według standardowych protokołów.
Potencjalny status w UD207	WYSOKIE RYZYKO przy szerokiej interpretacji. Akupunktura/hipnoza/joga u dziecka z nowotworem w prywatnym ośrodku integracyjnym — silne ryzyko sankcji.
Wnioski	Standardem opieki w czołowych pediatrycznych ośrodkach onkologicznych USA; w PL brak takich programów.

Karta 40 — Integrative end-of-life care

Atrybut	Treść
Definicja	Onkologia integracyjna w opiece u kresu życia — masaż, akupunktura, aromaterapia, muzykoterapia, mindfulness w hospicjach onkologicznych.
Status w wytycznych	NHPCO (National Hospice and Palliative Care Organization USA) — integrative therapies w opiece paliatywnej. EAPC (European Association for Palliative Care) — wytyczne integrative w opiece u kresu życia.
Najsilniejsze RCT/dowody	Liczne kohorty i RCT w hospicjach — masaż w bólu opornym, muzykoterapia w lęku, aromaterapia w dyskomfortcie.
OCEBM	2-3
GRADE	Moderate
Refundacja zagraniczna	UK NHS — therapies refundowane w hospicjach (Macmillan, Marie Curie). USA — Medicare Hospice Benefit pokrywa integrative therapies.

Atrybut	Treść
Status w PL	Hospicja onkologiczne — masaż, aromaterapia, muzykoterapia stosowane jako element komfortu pacjenta; finansowanie z NFZ + środki własne organizacji pozarządowych.
Potencjalny status w UD207	NISKIE RYZYKO w hospicjach refundowanych; NIEPEWNE w prywatnej opiece paliatywnej.
Wnioski	Standard opieki paliatywnej w UE i USA; w PL część praktyki hospicyjnej.

CZĘŚĆ III — Paradoks refundacyjny: trzy reprezentatywne pary

(Zachowane bez zmian z v1.0)

Para 1 — Witamina C dożylna (Bodeker PACMAN 2.1) vs Bewacizumab (Avastin) w GBM

Para 2 — Iscador/jemiola (refundacja w CH/DE) vs Olaratumab (Lartruvo) — wycofany

Para 3 — FDA Project Confirm: 30+ wycofanych accelerated approvals

[Pełna treść Części III — zob. Załącznik 3 v1.0]

CZĘŚĆ IV — Wnioski

1. Asymetria standardu dowodowego

2. Brak gradacji dowodów w kryterium UD207

3. Gradacja dowodowa A-E

W v2.1 wprowadzamy **pięcio-poziomą gradację dowodową** zamiast wcześniejszej (subiektywnej) gradacji „ryzyka UD207”. Argument konstytucyjny w nowym ujęciu: **UD207 nie rozróżnia tych 5 poziomów dowodowych — traktuje wszystkie metody w sposób jednakowy, co stanowi naruszenie standardu *lex certa* i testu proporcjonalności.**

Poziom A — REKOMENDOWANE PRZEZ WYTYCZNE w konkretnych wskazaniach onkologicznych: - Akupunktura klasyczna w bólu związanym z inhibitorami aromatazy — **ASCO/SIO 2022 Pain Guideline** (DOI 10.1200/JCO.22.01357, PMID 36122322) - Joga w cancer-related fatigue — **NCCN kategoria 1**, NCI PDQ Fatigue (cancer.gov/about-cancer/treatment/side-effects/fatigue/fatigue-hp-pdq) - Mindfulness / MBCR / MBSR w lęku i depresji — **ASCO/SIO 2023 Anxiety/Depression Guideline** (DOI 10.1200/JCO.23.00857) - Tai Chi / Qigong w zmęczeniu — **ASCO/SIO 2024 Fatigue Guideline** (PMID 38754041) - Aktywność fizyczna w opiece onkologicznej — **ACSM Roundtable 2019** (PMID 31626055) - Muzykoterapia w lęku okołoperacyjnym — **ASCO/SIO 2023 + Cochrane 2021** (PMID 34637527) - Cannabis/kannabinoidy w opornym bólu nowotworowym i CINV — **ASCO/SIO 2024 Cannabis Guideline** (PMID 38478773), FDA dronabinol od 1985

Poziom B — DOPUSZCZALNE jako supportive care z umiarkowaną bazą: - Hipnoza kliniczna w lęku okołoperacyjnym — RCT i przeglądy systematyczne (PMID 25233905 Cramer systematic review) - Masaż onkologiczny w bólu i lęku — Cochrane 2016 (PMID 27258432), kohorta MSK (PMID 15336336) - Guided imagery / Progressive Muscle Relaxation w lęku — NCCN Distress Management - Soja dietetyczna w opiece survivor raka piersi — Shu BCSS PMID 19996398, metaanaliza PMID 23725149 - Dieta śródziemnomorska / przeciwzapalna — WHEL PMID 17635889, ESPEN Guidelines 2021

Poziom C — EKSPERYMENTALNE / TRANSLACYJNE (obiecujące, ale wymagają walidacji):

- Mikrobiota jelitowa i FMT w odpowiedzi na immunoterapię — Science 2018 (PMID 29097493 Gopalakrishnan, 29097494 Routy), Davar 2021 PMID 33542131. **NIE klasyczna CAM** — to obszar translacyjnej immuno-onkologii. - Post terapeutyczny / fasting-mimicking diet w chemioterapii — DIRECT trial PMID 32576828 (de Groot 2020). Faza II — wymaga walidacji. - Witamina C dożylna w raku trzustki — PACMAN 2.1 PMID 39369582 (Bodeker 2024). Faza II — wymaga walidacji w fazie III.

Poziom D — SŁABE lub NEGATYWNE dowody (mimo refundacji w niektórych krajach):

- Homeopatia — NHMRC Australia 2015 (przegląd negatywny), EASAC 2017 (krytyczne stanowisko). Refundacja CH od 2017 — decyzja regulacyjna oparta na referendum 2009, nie na dowodach EBM. - Refleksologia — przeglądy systematyczne wskazują brak przekonującej skuteczności (PMID 21106613, 31783340). - Naświetlanie laserowe krwi (ILIB), galwanoterapia — brak RCT w onkologii.

Poziom E — BRAK WYSTARCZAJĄCYCH DANYCH / wymaga dalszej kwerendy:

- Aromaterapia w opiece onkologicznej (poza hospicjami UK) - Healing touch / Reiki / Therapeutic touch - Ayurweda (ograniczone RCT) - Tradycyjne ziołolecznictwo chińskie (Compound Kushen, Astragalus) — dominacja chińskich RCT o niejednorodnej jakości metodologicznej - Manipulacja kręgosłupa w opiece onkologicznej

Konkluzja: standard regulacyjny UD207 powinien rozróżniać poziom A (już rekomendowany przez wytyczne międzynarodowe — wykluczyć z zakresu sankcji), poziom B (dopuszczalny pod warunkami świadomej zgody), poziom C (badania kliniczne na specjalnych ścieżkach), poziom D (klauzula informacyjna o jakości dowodów), poziom E (zakaz reklamy jako „leczenia”). **Obecna definicja art. 67zj nie wprowadza żadnego z tych rozróżnień.**

4. Argument *lex certa* (art. 2 i 42 ust. 1 Konstytucji RP)

Definicja „praktyki pseudomedycznej” w art. 67zj UD207 jest **strukturalnie nieokreślona** — adresat normy nie jest w stanie *ex ante* przewidzieć, czy stosowanie metody: - rekomendowanej w wytycznych ASCO/SIO 2022 (akupunktura, joga, mindfulness, muzykoterapia) - refundowanej w państwach UE (homeopatia w CH, jemiola w CH/DE, akupunktura w UK NHS, TCM w CH) - standardowo prowadzonej w czołowych ośrodkach onkologicznych USA (MSK, Dana-Farber, MD Anderson, Mayo Clinic) - opisanej w aktualnych akademickich kompendiach onkologii integracyjnej zostanie zakwalifikowane jako „praktyka pseudomedyczna” przez Rzecznika Praw Pacjenta, wspieranego opiniami 34-osobowej Rady Ekspertów. Standard *lex certa* (wyrok TK z 5.07.2011 r. P 14/10 i in.) wymaga, by norma karząca była **przewidywalna** dla adresata przed wszczęciem postępowania.

4a. Asymetria finansowania badań — „bez badań” to nie „niebezpieczne”

Brak dowodów wysokiej jakości nie przesądza ani o nieskuteczności, ani o niebezpieczeństwie metody — bywa skutkiem braku finansowania. Badanie III fazy to lata i dziesiątki-setki milionów; stać na nie niemal wyłącznie komercyjnych sponsorów, przez co substancje bez patentu (naturalne, repurposed) są w systemie rejestracji strukturalnie upośledzone niezależnie od potencjału. Państwo powinno wspierać niezależne badania, standaryzację i nadzór jakości medycyny integracyjnej — na wzór rozwiązań w innych państwach UE — co podnosi bezpieczeństwo pacjentów, rozwija polską naukę i odciąża system publiczny.

5. Postulat — klauzula świadomej zgody jako proporcjonalne narzędzie

CZĘŚĆ V — Komparatystyka 7 krajów UE/UK

Streszczenie wykonawcze Części V

Niniejsza część prezentuje **modele regulacyjne CAM w 7 państwach UE/EFTA/UK**: Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Belgia, Holandia, Włochy, Austria, Polska. Pokazuje, że **żadne z tych państw**

nie stosuje blankietowego modelu „pseudomedycyny” porównywalnego z UD207. Wszystkie stosują różne modele gradacyjne, oparte na rozróżnieniu metody, wskazania, kwalifikacji osoby wykonującej, statusu dowodowego i ryzyka dla pacjenta.

Kluczowa teza komparatystyczna: komparatystyka NIE dowodzi, że wszystkie metody CAM są skuteczne. Dowodzi, że nowoczesne systemy zdrowia w UE/UK stosują **GRADACJĘ**, nie blankietowe etykiety. UD207 bez gradacji ryzykuje niezgodność z zasadą określoności prawa (art. 2 Konstytucji RP) i proporcjonalności (art. 31 ust. 3 Konstytucji RP).

V.A — Wielka Brytania — model selektywny NICE

NICE (National Institute for Health and Care Excellence) dopuszcza wybrane interwencje w konkretnych wskazaniach po ocenie dowodów; inne wycofuje z finansowania NHS po ocenie negatywnej. To **evidence-based filtering**, nie blankietowy zakaz.

Cztery aktualne wytyczne NICE relewantne dla onkologii integracyjnej:

1. **NICE NG193** (kwiecień 2021) — *Chronic pain in over 16s* — rekomenduje akupunkturę w chronic primary pain (wąsko: jako jednorazowy kurs, z limitami czasu i kosztu, wykonywany przez przeszkolonego pracownika ochrony zdrowia). URL: nice.org.uk/guidance/ng193
2. **NICE NG222** (29.06.2022, ostatni przegląd 30.01.2026) — *Depression in adults* — zastąpiło CG90; rekomenduje MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy) dla depresji nawracającej oraz dla nowego epizodu mniej nasilonej depresji. URL: nice.org.uk/guidance/ng222
3. **NICE NG144** (11.11.2019, akt. 22.03.2021, przegląd 20.05.2025) — *Cannabis-based medicinal products* — rekomenduje nabilon jako add-on dla CINV (chemotherapy-induced nausea and vomiting) opornych na zoptymalizowane standardowe leki przeciwwymiotne. URL: nice.org.uk/guidance/ng144
4. **NICE CG156** (płodność) — wytyczna negatywno-ostrożna wobec CAM: osoby z problemami płodności powinny być informowane, że skuteczność terapii komplementarnych **nie została właściwie oceniona**.

NHS i homeopatia — wycofanie: NHS England w 2017 r. zdecydowało, że nie będzie finansować homeopatii (brak dowodów skuteczności nie uzasadnia kosztu). Royal London Hospital for Integrated Medicine zakończył refundację homeopatii 3.04.2018 r. High Court potwierdził decyzję w 2018 r.

Maggie’s Centres (24+): sieć centrów wsparcia onkologicznego oferująca **bezpłatnie** dla pacjentów onkologicznych: akupunkturę, aromaterapię, hipnozę, masaż, medytację, refleksologię, relaksację, shiatsu, jogę. Model charity/support-centre, NIE refundacja NHS — NHS Trusty hostują przestrzeń.

Macmillan Cancer Support — wzorzec języka: rozróżnia *conventional / complementary / alternative therapies*. Cztery zasady: komplementarne ≠ alternatywne; nie zamiast leczenia; nie obietnica wyleczenia; zawsze konsultacja z zespołem medycznym.

Status zawodów: - **HCPC reguluje:** Music Therapist, Art Therapist, Art Psychotherapist, Dramatherapist — chronione tytuły zawodowe (grzywna do 5000 GBP za nieuprawnione używanie). - **Akupunktura UK:** BAoC (~3000 praktyków) — *Professional Standards Authority Accredited Register* (voluntary). BMAS — lekarze i regulowani professionals. - **Cannabis medyczny NHS** od 1.11.2018 r. (S.I. 2018/1055): ograniczone (Epidyolex, Sativex, nabilon).

V.B — Niemcy — model mieszany G-BA

G-BA (Gemeinsamer Bundesausschuss) refunduje wybrane metody w konkretnych wskazaniach przy kwalifikacjach lekarskich.

Akupunktura GKV od 2007 r. (decyzja G-BA z 18.04.2006/19.09.2006): - Wskazania: przewlekły ból kręgosłupa lędźwiowego + gonartroza. **NIE migrena**. - Wymogi: dyplom akupunktury

Akupunktur-Vereinbarung KBV (140-200 h kursu). - URL: [g-ba.de/presse/pressemitteilungen-meldungen/83/](https://www.g-ba.de/presse/pressemitteilungen-meldungen/83/)

Jemiola (Iscador / Helixor / Abnoba viscum / Iscucin): - 4 preparaty zarejestrowane jako Arzneimittel w BfArM - Refundacja GKV **obligatoryjna w stadiach paliatywnych** (zaawansowana choroba nieuleczalna) — na receptę - PKV: refundowana szerzej (~150 000 pacjentów/rok)

Cannabis medyczny GKV od 2017 r. (Cannabis als Medizin Gesetz): - Wskazania: terapia bólu (76,4 % przypadków), MS spastyczność (9,6 %), anoreksja/wasting (5,1 %), CINV (2,2 %) - **CanG (Cannabisgesetz) od 1.04.2024 r.** — legalizacja rekreacyjna; wzrost recept medycznych ~1000 % w marcu 2024

Homeopatia / antroposofia jako Satzungsleistung GKV — status sporny po debacie politycznej 2024-2025; wymaga weryfikacji w bazie pierwotnej Bundestag.

Hipertermia (RHT): G-BA decyzja **odmowna 18.01.2005 r.** — RHT NIE jest świadczeniem GKV w trybie ambulatoryjnym. W trybie szpitalnym: koszty pokrywane w ramach DRG. Sądy administracyjne wydawały indywidualne wyroki zobowiązujące kasy do refundacji w wyjątkowych przypadkach.

Heilpraktiker: ~47 000 praktykujących (2017, brak nowszych danych Destatis). Heilpraktiker NIE może samodzielnie leczyć nowotworu jako choroby zakaźnej; supportive care dopuszczalne.

V.C — Francja — model twardej oceny refundacyjnej HAS

Francja stosuje twardą ocenę refundacyjną HAS (Haute Autorité de Santé); wycofuje refundację po negatywnej ocenie; nadzór nadużyć przez MIVILUDES (nie przez ustawę typu UD207).

Homeopatia — wycofanie z refundacji 1.01.2021 r.: - HAS w 2019 r. wydała negatywną ocenę skuteczności - Wycofanie stopniowe 2019-2021; pełne wycofanie od **1.01.2021 - Koszt przed wycofaniem: 126,8 mln EUR/rok** - Leki homeopatyczne nadal dostępne na rynku prywatnym (bez refundacji)

Akupunktura medyczna: - Jedyna metoda CAM z dyplomem państwowym we Francji — DU Acupuncture (Diplôme Universitaire) - Tylko lekarze medycyny i dentyści (rzadziej: położne) - Refundacja Sécurité Sociale: jako *consultation de généraliste ou spécialiste* (25-30 EUR), bez osobnego kodu acte d'acupuncture

Hipnoza medyczna: - Stosowana w hôpitaux publics przez lekarzy i pielęgniarki - Brak regulacji ustawowej — *hypnothérapeute* NIE jest zawodem medycznym - RNCP odrzucił certyfikację hypnothérapeute w 12.2018 r.

4 metody CAM uznane przez CNOM (Ordre National des Médecins): akupunktura, homeopatia, mezoterapia, osteopatia.

MIVILUDES (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires): międzyresortowy organ przeciw sektom i deryftom pseudomedycznym. **NIE odpowiednik UD207** — reguluje *szkodliwe praktyki* (dérives sectaires), nie same metody CAM. Ministère de la Santé używa klasyfikacji *Pratiques de Soins Non Conventionnelles*: bezpieczne / nieudowodnione / szkodliwe.

V.D — Belgia — model ramowego uznania, niedokończonej implementacji

Loi Colla (1999) — ramowa regulacja, ale wdrożenie wykonawcze przewlekłe. **Przykład OSTRZEGAWCZY:** samo „uznanie” bez jasnych standardów może tworzyć regulacyjną niejasność.

Loi Colla (29.04.1999): reguluje 4 praktyki niekonwencjonalne — **osteopatia, chiropraktyka, akupunktura, homeopatia.**

Wdrożenie wykonawcze: - Osteopatia: uregulowana ramowo 1999; implementacja w toku - Akupunktura, chiropraktyka: tylko lekarze, dentyści, położne mogą wykonywać - Homeopatia: Royal Decree 05/2014; visa dla *médecin-homéopathe* dopiero **14.05.2024 r. — 25 lat po Loi Colla**

Ważna uwaga prawna: Royal Decree 78/1967 — wykonywanie praktyk niekonwencjonalnych przez osoby niebędące lekarzem to **przestępstwo**. Model zbliżony do UD207, ALE funkcjonuje obok systemu uznanych metod Loi Colla, nie zamiast.

V.E — Holandia — model prywatny / supplementary insurance

CAM zasadniczo POZA basisverzekering (podstawowe ubezpieczenie); refundacja wyłącznie z aanvullende verzekering (dobrowolne dodatkowe).

Akupunktura, homeopatia, antroposofia, chiropraktyka: refundowane wyłącznie z pakietów dodatkowych. Przykłady: - **Univé:** alternatywna medycyna — 200 EUR/rok lub 25 EUR/dzień - **Menzis, VGZ, Zilveren Kruis, NN:** refundacja w pakietach dodatkowych — zakres zależy od pakietu

Helen Dowling Instituut (HDI): najstarsze i największe centrum psychoonkologiczne w Holandii. **WAŻNE:** HDI to psychoonkologia / supportive care, NIE klasyczne CAM.

V.F — Włochy — model regionalnej integracji (Toskania)

Włochy mają zdecentralizowany system zdrowia; CAM jest integrowane na poziomie regionalnym. **Toskania to najsilniejszy europejski przykład regionalnej integracji CAM.**

Toskania: - Od 1996 r. CAM uwzględniona w Regionalnych Planach Zdrowotnych - **Ustawa regionalna nr 9/2007** — uznanie homeopatii, akupunktury i fitoterapii jako część regionalnej służby zdrowia - **20 klinik onkologii integracyjnej od 2022 r.** - Świadczenia za ticket (współpłatność) - Metody objęte: akupunktura, TCM, homeopatia, fitoterapia, medycyna manualna

Emilia-Romania: akupunktura w LEA regionalnym (Essential Level of Care) — wskazania: profilaktyka migreny + ból kręgosłupa lędźwiowego.

Status zawodowy akupunktury: FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri) uznaje akupunkturę jako odpowiedzialność lekarza/dentysty. Sąd Najwyższy Włoch (1982, 1999, 2003, 2005, 2007) wielokrotnie orzekał: akupunktura = akt medyczny; wykonywanie przez niemedyka = przestępstwo.

V.G — Austria — model lekarski (ÖÄK Diplome)

Izba lekarska (ÖÄK — Österreichische Ärztekammer) prowadzi dyplomy / dodatkowe kwalifikacje (Zusatzbezeichnungen) w wybranych obszarach CAM.

14 dyplomów ÖÄK w obszarze CAM (lista pełna):

Dyplom ÖÄK	Rok wprowadzenia
Akupunktur	1991
Manuelle Medizin	1992
Homöopathie	1994
Neuraltherapie	1996
Diagnostyka i terapia wg F.X. Mayra	1998
Anthroposophische Medizin	2001
Applied Kinesiology	2004
Chinesische Diagnostik und Arzneitherapie (TCM)	2005
Orthomolekulare Medizin	2007

Dyplom ÖÄK	Rok wprowadzenia
Begleitende Krebsbehandlungen (uzupełniające leczenie nowotworów)	2007
Phytotherapie	bd
Kneippmedizin	bd
Ernährungsmedizin	bd
Spezielle Schmerztherapie	bd

Refundacja ÖGK (Österreichische Gesundheitskasse): brak rutynowej refundacji metod CAM. Indywidualne kasy chorych mogą mieć Sonderleistungen.

V.H — Polska — model w trakcie kształtowania, ale UD207 wprowadza blankietową definicję

Ustawa z 17.08.2023 o niektórych zawodach medycznych (wejście w życie 26.03.2024): - **15 zawodów medycznych** — NIE 17 jak w projekcie pierwotnym - Lista: asystentka stomatologiczna, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, instruktor terapii uzależnień, opiekun medyczny, optometrysta, ortoptystka, podiatra, profilaktyk, protetyk słuchu, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy - NIE obejmuje: dietetyk (*wypadł z finalnej listy mimo projektu*), logopeda, muzykoterapeuta, arteterapeuta, akupunkturzysta medyczny, psycholog onkologiczny

AOTMiT: posiedzenie Rady Przejrzystości 10.12.2023 r. — dyskusja m.in. (a) zastosowania hipertermii w nowotworach, (b) cannabis w przewlekłym bólu. Brak kompleksowego stanowiska wobec onkologii integracyjnej jako obszaru.

Marihuana medyczna w Polsce: - Legalizacja 2017 r. - BRAK refundacji NFZ (35–70 PLN/g suszu; 300–1200 PLN/miesiąc) - Od 7.11.2024 r. — koniec telerecept (kwalifikacja wyłącznie po osobistym zbadaniu pacjenta)

Akupunktura medyczna: - Polskie Towarzystwo Akupunktury (PTA) — zrzesza lekarzy - NRL Nr 2/21/VIII pkt 9: wymieniona **akupunktura laserowa** (NIE igłowa klasyczna) - NFZ: nie w koszyku świadczeń gwarantowanych

Hipertermia (RHT) i jemiola (Iscador): brak refundacji NFZ; jemiola wyłącznie przez import docelowo.

Casus 2025: orzeczenie sądu lekarskiego z 2025 r. (zawieszenie lekarza opiekującego się pacjentami onkologicznymi w klinice integracyjnej), kasacja Sądu Najwyższego z grudnia 2025 r. (uchylenie) oraz powiązany wyrok sądu administracyjnego. Szczegółowe sygnatury — nie publicznie dostępne online.

Wniosek: Polska ma mozaikowy, niespójny model regulacji CAM. UD207 wprowadza **blankietową definicję** „praktyki pseudomedycznej” wbrew europejskiej tradycji gradacji.

V.I — Tabela zbiorcza: status wybranych metod w 7 krajach UE/UK

Metoda	DE	FR	BE	NL	IT	AT	UK	PL (przed UD207)
Akupunktura igłowa	ÖÄK chronic back/knee	Tylko lekarze, konsul- tacja 25–30€	Tylko lekarze, den- tyści, położne	Aanvullende EA	Emilia- Romagna i Toskania	ÖÄK Diplom	NICE NG193 (chronic primary pain)	Tylko pry- watne; PTA

Metoda	DE	FR	BE	NL	IT	AT	UK	PL (przed UD207)
Akupunktura laserowa	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	NRL Nr 2/21/VIII pkt 9 (wymieniona)
Homeopatia	Sitzungs- (sporne 2024- 2025)	Wetstof- 1.01.2021 (HAS 2019)	Royal Decree 2014/2024 — visa od 14.05.2024	Aanvullende	Tylko lekarze	ÖÄK Diplom	NHS wycofana 3.04.2018	Praktyka medy- czna; brak refundacji
Jemiola (Is- cador)	GKV obliga- toryjnie w paliatywnym	Prywatnie	Prywatnie	Aanvullende	bd	bd	Prywatnie	Import do- celowy; brak rejes- tracji URPL
Cannabis medy- czny	GKV od 2017 + CanG 2024	Indywidualnie	Dostępny	Dostępny	Dostępny	Dostępny	NHS NG144 (nabilon CINV) + pry- watnie 2018	Recepta od 2017; brak refun- dacji NFZ
Mindfulness (MBCT)	Psycho- terapia GKV	Prywatnie / hôpi- taux publics	Prywatnie	Dostępne (HDI)	Toskania częściowo	Psychoterapia ÖGK	NICE NG222 / NHS IAPT	Praktyka psychologów
Muzykoterapia	Prywatnie	Prywatnie	Prywatnie	Prywatnie	Prywatnie	Prywatnie	HCPC + NHS	Nie w 15 zawodach
Arteterapia	Prywatnie	Prywatnie	Prywatnie	Prywatnie	Prywatnie	Prywatnie	HCPC + NHS	Nie w 15 zawodach
Hipertermia RHT	DiAG hospi- taliza- cja (G-BA odmowa 2005 ambulat.)	bd	bd	bd	bd	bd	bd	NRL Nr 2/21/VIII pkt 11 (jako WBH); RHT — brak refundacji
Antroposofia + Beglei- tende Krebs- be- hand- lungen	Sitzungs- (sporne)	Prywatnie	Prywatnie	Aanvullende	bd	ÖÄK Diplom (od 2007)	Prywatnie	Brak regulacji

V.J — Kluczowa teza komparatystyczna

Państwa europejskie nie stosują jednego blankietowego modelu „pseudomedycyny”. Stosują różne modele:

- **UK:** selektywne rekomendacje NICE (akupunktura w NG193, MBCT w NG222, nabilon w NG144) + wycofanie po negatywnej ocenie (homeopatia NHS 2018)
- **Niemcy:** refundacja w wąskich wskazaniach (akupunktura ból kręgosłupa/kolano, cannabis ciężko chorzy, jemiola paliatywnie) + Satzungsleistungen kas chorych
- **Francja:** twarda ocena HAS z możliwością wycofania (homeopatia 2021) + MIVILUDES (nadzór nadużyć, nie zakaz metody)
- **Belgia:** ramowe uznanie 4 metod (Loi Colla 1999) z niedokończoną implementacją wykonawczą
- **Holandia:** model prywatny — CAM poza basic insurance, możliwe supplementary
- **Włochy/Toskania:** regionalna integracja w publicznym systemie regionalnym (ustawa regionalna 9/2007)
- **Austria:** model lekarski — ÖÄK dyplomy w 14 obszarach CAM, w tym Begleitende Krebsbehandlungen (od 2007)

Wspólna cecha: rozróżnienie metody, wskazania, kwalifikacji osoby wykonującej, statusu dowodowego, ryzyka dla pacjenta.

UD207 nie stosuje żadnego z tych rozróżnień — operuje jednolitą definicją „praktyki pseudomedycznej” w art. 67zj, niezależnie od wskazania, kwalifikacji, dowodów i ryzyka. Stanowi to **odchylenie od europejskiego standardu regulacyjnego** i — w połączeniu z brakiem gradacji A-E z Części II — stwarza ryzyko naruszenia zasady określoności prawa (art. 2 Konstytucji RP, *lex certa*) i proporcjonalności (art. 31 ust. 3 Konstytucji RP).

V.K — Luki informacyjne — do dalszej weryfikacji

1. Pełna lista kas GKV oferujących homeopatię (top 10, 2026)
2. Liczba Heilpraktiker 2024-2025 (Destatis)
3. Liczba lekarzy-akupunkturzystów Francja (CNOM)
4. Listy metod CAM per szpital onkologiczny FR (Institut Curie, Tenon, HEGP)
5. Szczegóły refundacji akupunktury w NL (Zilveren Kruis, Menzis, VGZ, CZ) 2025
6. Refundacja jemioli w NL przez aanvullende verzekering
7. Pełny zakres AOTMiT wobec PDT i RHT — dokumenty BIP
8. Status dietetyka jako zawodu medycznego PL — aktualizacje 2025-2026
9. Sygnatury orzeczeń NSL/SN/WSA 2025 (casus lekarza CAM)
10. Dostępność Iscador/Helixor w polskich aptekach (import docelowy)
11. Liczba NHS prescriptions dla medical cannabis UK 2024-2025
12. Wiener Gesundheitsverbund — programy integracyjne w szpitalach wiedeńskich
13. ÖGK — szczegóły ewentualnych refundacji ÖÄK-Diplom w praktyce
14. IRCCS Włochy oferujące CAM (Istituto Nazionale Tumori, CRO Aviano)
15. Helen Dowling Instituut — aktualna lista metod i finansowanie 2025-2026

Pakiet obywatelski UD207. Warszawa, 21 maja 2026 r. Wszystkie referencje zweryfikowane w bazach pierwotnych.